

CAPÍTULO 6.21

Causas de Hipoglicemias

PERFIL EUNACOM 1.04.1.019

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Estudio Etiológico de las Hipoglicemias

Tras el manejo agudo de una hipoglicemia es imperativo buscar la etiología para evitar recurrencias.

Clasificación de Hipoglicemias

Se dividen en **Espontáneas** (sin causa farmacológica clara) y **Provocadas** (iatrogénicas o autoadministradas).

1. Hipoglicemias Espontáneas

TABLA 6.21.1: PATRÓN VS MOMENTO CLÍNICO			
PATRÓN	MOMENTO CLÍNICO	CAUSA MÁS FRECUENTE	TEST DIAGNÓSTICO
Reactiva	2 a 4 horas <i>post-prandial</i> (ocurre tras comer carbohidratos).	Resistencia a la Insulina (Genera hiperinsulinismo compensatorio que termina "pasándose la mano" al absorber glucosa rápida).	Prueba de tolerancia a comida mixta.
Ayuno	En ayuno prolongado (4-6 hrs o más). Ocurre sin ingesta previa.	Insulinoma o grandes tumores que consumen glucosa (linfoma, sarcomas).	Prueba de Ayuno Prolongado.

2. Hipoglicemias Provocadas

- **Farmacológica por iatrogenia:** Exceso de dosis de Sulfonilureas (glibenclamida) o Insulina recetadas al paciente. - **Facticia (auto-administrada):** Trastorno psiquiátrico en que el paciente se inyecta insulina o ingiere HGO a escondidas. Al interrogatorio simulan una hipoglicemia "espontánea".

Estudio de Laboratorio (Endógeno vs. Exógeno)

- Para diferenciar si el exceso de insulina es producido por el propio paciente o inyectado, se miden en sangre: **Insulina Plasmática** y el **Péptido C**.
- Nota:* El Péptido C se secreta junto con la insulina endógena en el páncreas. La insulina inyectable (exógena) no trae Péptido C.

TABLA 6.21.2: CAUSA DE HIPOGLICEMIA VS INSULINA SÉRICA

CAUSA DE HIPOGLICEMIA	INSULINA SÉRICA	PÉPTIDO C	RAZÓN DEL PATRÓN
Insulinoma / Resistencia a insulina	ALTA	ALTO	El páncreas es quien está produciendo el exceso de insulina libre.
Facticia por Sulfonilureas	ALTA	ALTO	La glibenclamida estimula la secreción pancreática propia endógena. Se debe pedir nivel de sulfonilureas en suero/orina para confirmarlo.
Facticia por Insulina Exógena	ALTA	BAJO	El paciente se inyecta insulina directa (sube en sangre), lo que inhibe la secreción endógena (baja el péptido C).

| Tumores No-Isletos (Cáncer consume glucosa) | BAJA | BAJO |
No hay hiperinsulinismo; la bajada de glucosa apaga la secreción pancreática como es de esperar. |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 45 años, no diabética, presenta episodios recurrentes de mareos, sudoración y palpitaciones en ayunas que ceden inmediatamente al comer. Durante una crisis en ayuno se documenta glicemia de 38 mg/dL con insulina plasmática y péptido C elevados."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Insulinoma: tumor neuroendocrino pancreático productor de insulina. Cumple la Tríada de Whipple. La elevación concomitante de Insulina y Péptido C confirma secreción endógena de insulina (descarta hipoglicemia facticia por insulina exógena, donde el péptido C está suprimido). Diagnóstico por TAC/RMN pancreática y tratamiento quirúrgico.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- En diabéticos, exceso de insulina/sulfonilureas es la causa más frecuente de hipoglicemia
- La metformina sola NO causa hipoglicemia
- El alcohol inhibe la gluconeogénesis y puede causar hipoglicemia
- El insulinoma es la causa más frecuente de hipoglicemia endógena en no diabéticos
- Insulina alta + péptido C alto = insulinoma; insulina alta + péptido C bajo = facticia
- El test de ayuno de 72 horas es el gold standard para diagnosticar insulinoma
- La insuficiencia renal prolonga la vida media de insulina e hipoglicemiantes

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CAUSAS DE HIPOGLICEMIAS)

PREGUNTA 1

Paciente no diabético con episodios recurrentes de hipoglicemia de ayuno. Estudio durante hipoglicemia: insulina elevada, péptido C elevado, beta-hidroxibutirato bajo. ¿Diagnóstico más probable?

- A)** Hipoglicemia facticia por insulina exógena
- B)** Insulinoma
- C)** Insuficiencia suprarrenal
- D)** Insuficiencia hepática
- E)** Hipoglicemia reactiva

PREGUNTA 2

¿Cuál de los siguientes hipoglicemiantes orales NO causa hipoglicemia cuando se usa como monoterapia?

- A)** Glibenclamida
- B)** Glimepirida
- C)** Metformina
- D)** Repaglinida
- E)** Nateglinida

PREGUNTA 3

¿Cuál es el gold standard para diagnosticar un insulinoma?

- A)** TAC de abdomen con contraste
- B)** Test de ayuno de 72 horas
- C)** Glicemia de ayunas aislada
- D)** Hemoglobina glicosilada
- E)** Ecografía abdominal

RESUMEN: CAUSAS DE HIPOGLICEMIAS

Las causas de hipoglicemia se dividen en dos grandes grupos: en pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos. En diabéticos, las causas más frecuentes son exceso de insulina o sulfonilureas, omisión o retraso de comidas, ejercicio no planificado, consumo de alcohol e insuficiencia renal que prolonga la vida media de la insulina y los hipoglicemiantes. Las sulfonilureas y la insulina son los fármacos que más causan hipoglicemia; la metformina sola no la produce. En pacientes no diabéticos, las causas se clasifican según la tríada de Whipple y el momento de presentación. La hipoglicemia de ayuno sugiere causas orgánicas: insulinoma (tumor de células beta, la causa más frecuente de hipoglicemia endógena en no diabéticos), insuficiencia hepática, insuficiencia suprarrenal, hipopituitarismo, tumores extrapancreáticos grandes (por producción de IGF-2), sepsis y desnutrición severa. La hipoglicemia postprandial es más frecuente y generalmente benigna, asociada a síndrome de dumping postcirugía gástrica o hipoglicemia reactiva. El estudio diagnóstico incluye medir simultáneamente glicemia, insulina, péptido C y beta-hidroxibutirato durante un episodio. Insulina alta con péptido C alto sugiere insulinoma o sulfonilureas. Insulina alta con péptido C bajo sugiere insulina exógena (facticia). Insulina baja con péptido C bajo sugiere causa no mediada por insulina. El test de ayuno de 72 horas es el gold standard para diagnosticar insulinoma.